DOCUMENTO DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

Gabriel Moreira de Souza
Hugo Guilherme Vaz Mesquita
Ludmila Lima Do Espírito Santo
Victor Alcanfor Concentino

DOCUMENTO DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS **1**
Sistema de Gestão para Clínica de Psicologia 1
1. INTRODUÇÃO **2**
2. ANÁLISE DE SISTEMA ANÁLOGO **2**
3. LEVANTAMENTO E SÍNTESE DOS REQUISITOS **3**
3.1 Síntese das Entrevistas 3
3.2 Síntese dos Questionários 4
4. MODELAGEM DO PROCESSO DE NEGÓCIO (BPMN) **4**
4.1 Entendimento do Processo Atual 4
4.2 Modelagem do Processo Atual (AS-IS) 4
Figura 1 – Processo de agendamento e atendimento clínico (AS-IS) 5
4.3 Modelagem do Processo Proposto (TO-BE) 5
Figura 2 – Processo de agendamento e atendimento clínico (TO-BE) 6
5. REQUISITOS DO SISTEMA **6**
5.1 Requisitos Funcionais 6
5.2 Requisitos Não Funcionais 7
5.3 Regras de Negócio 8
5.4 Casos de Uso 8
5.5 Interfaces do Sistema 8
5.6 Critérios de Aceitação 9
5.7 Diferenciais do Sistema 9
6. MATRIZ DE RASTREABILIDADE **9**
6.1 Visão Geral 9
6.2 Matriz de Rastreabilidade 9
6.3 Requisitos Não Funcionais 11
6.4 Análise Consolidada 11

1. INTRODUÇÃO

O presente documento tem como objetivo apresentar o levantamento de requisitos para o desenvolvimento de um sistema de gestão voltado para clínicas de psicologia. A proposta do sistema surge a partir da necessidade de organizar e otimizar processos que, atualmente, são realizados de forma manual ou com o uso de ferramentas desconectadas.

O desenvolvimento deste trabalho foi baseado em três pilares principais: análise de sistemas já existentes no mercado, entrevistas com profissionais da área e aplicação de questionários estruturados. A partir dessas fontes, foi possível compreender o funcionamento atual das clínicas, identificar dificuldades recorrentes e levantar oportunidades de melhoria.

De modo geral, observou-se que grande parte dos profissionais utiliza múltiplas ferramentas para gerenciar suas atividades, como cadernos, planilhas e aplicativos de mensagem. Essa fragmentação das informações gera retrabalho, aumenta a chance de erros e dificulta o controle geral das operações.

Diante desse cenário, este documento busca consolidar os requisitos necessários para o desenvolvimento de um sistema integrado, capaz de centralizar informações, automatizar tarefas e melhorar a eficiência no atendimento e na gestão da clínica.

---

2. ANÁLISE DE SISTEMA ANÁLOGO

A análise de sistemas análogos foi realizada com o objetivo de compreender como soluções já existentes atendem às demandas clínicas de psicologia. Para isso, foi utilizado como referência o sistema Psicoplanner.

O Psicoplanner é uma ferramenta voltada principalmente para psicólogos autônomos e clínicas de pequeno e médio porte, oferecendo funcionalidades voltadas à organização da rotina de atendimentos, registro de informações clínicas e controle financeiro básico.

O sistema se estrutura em torno de três principais módulos: agenda, prontuário e financeiro.

A agenda funciona como o núcleo do sistema, permitindo visualizar os atendimentos organizados por período, além de possibilitar agendamentos, cancelamentos e

reagendamentos. Também há controle de faltas, o que auxilia no acompanhamento dos pacientes.

O prontuário eletrônico permite registrar a evolução dos atendimentos, mantendo um histórico individual para cada paciente. Esse registro é essencial para o acompanhamento clínico e organização das informações ao longo do tempo.

No módulo financeiro, o sistema permite registrar pagamentos e acompanhar consultas realizadas ou pendentes. Embora funcional, esse módulo apresenta limitações em relação a recursos mais avançados de gestão.

Outro recurso presente é o envio de lembretes de consulta, que contribui para a redução de faltas e melhora na organização da agenda.

Em termos de usabilidade, o sistema se destaca pela simplicidade e facilidade de uso. No entanto, essa simplicidade também limita sua flexibilidade, uma vez que há poucas opções de personalização, relatórios mais simples e baixa integração com outras ferramentas.

A análise permitiu identificar funcionalidades essenciais para o domínio, como gestão de agenda, prontuário eletrônico e controle financeiro, além de evidenciar oportunidades de melhoria, especialmente em relação à integração, personalização e escalabilidade do sistema.

---

3. LEVANTAMENTO E SÍNTESE DOS REQUISITOS

3.1 Síntese das Entrevistas

As entrevistas realizadas com profissionais da área permitiram compreender, de forma prática, como ocorre a gestão das atividades em clínicas de psicologia.

Foi possível observar que muitos profissionais utilizam diferentes ferramentas para organizar suas rotinas, como cadernos, planilhas e aplicativos de comunicação. Essa falta de centralização dificulta o controle das informações e aumenta a carga de trabalho.

Entre as principais dificuldades relatadas, destacam-se problemas com agendamento, especialmente conflitos de horário, dificuldade na organização dos prontuários, controle financeiro manual e comunicação com pacientes feita de forma repetitiva.

Outro ponto relevante é a sobrecarga de funções, uma vez que muitos profissionais acumulam atividades administrativas além do atendimento clínico.

A partir dessas entrevistas, foram identificadas necessidades como:

- centralização das informações em um único sistema
- automação de lembretes de consulta
- prontuário eletrônico de fácil preenchimento
- controle financeiro simplificado
- suporte a múltiplos profissionais

3.2 Síntese dos Questionários

Os questionários aplicados permitiram obter uma visão mais estruturada das necessidades dos usuários.

O agendamento foi identificado como uma das funcionalidades mais críticas, incluindo diferentes tipos de atendimento e necessidade de controle de faltas e reagendamentos.

O prontuário eletrônico foi apontado como essencial, devendo conter informações completas e permitir registro rápido após as sessões.

No aspecto financeiro, observou-se a necessidade de suporte a diferentes formas de pagamento e controle de contas.

A comunicação com pacientes também se destacou como ponto crítico, com forte demanda por automação de lembretes e notificações.

Além disso, foi identificada uma preocupação significativa com a segurança e privacidade dos dados dos pacientes.

---

4. MODELAGEM DO PROCESSO DE NEGÓCIO (BPMN)

4.1 Entendimento do Processo Atual

O processo de atendimento em clínicas de psicologia ocorre de forma majoritariamente manual, utilizando ferramentas não integradas, como planilhas, cadernos e aplicativos de comunicação.

Esse processo envolve atividades como agendamento de consultas, atendimento clínico, registro de prontuário, controle financeiro e comunicação com pacientes.

A análise das entrevistas e questionários evidenciou os seguintes problemas:

- ausência de centralização das informações

- conflitos de agendamento
- comunicação manual com pacientes
- retrabalho operacional
- sobrecarga dos profissionais

4.2 Modelagem do Processo Atual (AS-IS)

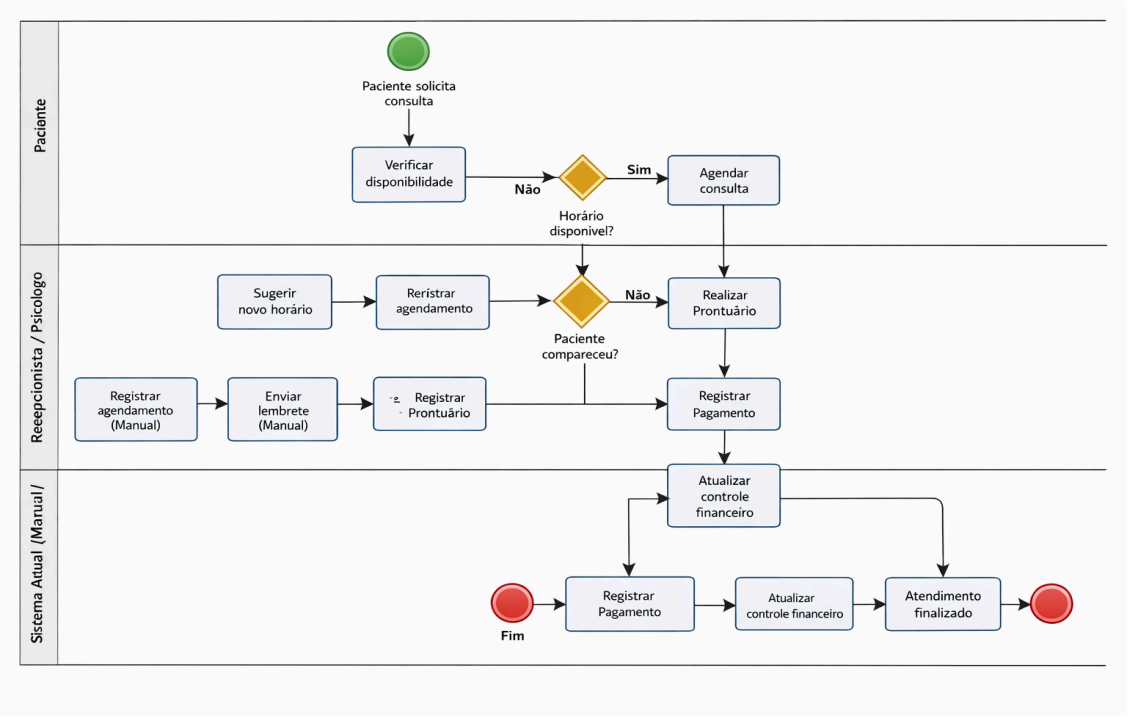
O processo atual foi modelado utilizando a notação BPMN, representando o fluxo real executado nas clínicas.

O processo inicia-se com a solicitação de consulta pelo paciente, seguida da verificação manual de disponibilidade de horários. Caso não haja disponibilidade, um novo horário é sugerido. Quando disponível, a consulta é agendada e registrada manualmente.

O envio de lembretes também ocorre de forma manual. No dia da consulta, verifica-se o comparecimento do paciente. Em caso de ausência, a falta é registrada; caso contrário, o atendimento é realizado.

Após o atendimento, o prontuário é preenchido, podendo ocorrer atrasos. O pagamento é registrado manualmente e o controle financeiro atualizado.

Figura 1 – Processo de agendamento e atendimento clínico (AS-IS)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.3 Modelagem do Processo Proposto (TO-BE)

Com base nas limitações identificadas no processo atual, foi proposto um novo fluxo com foco na automação e integração das atividades da clínica.

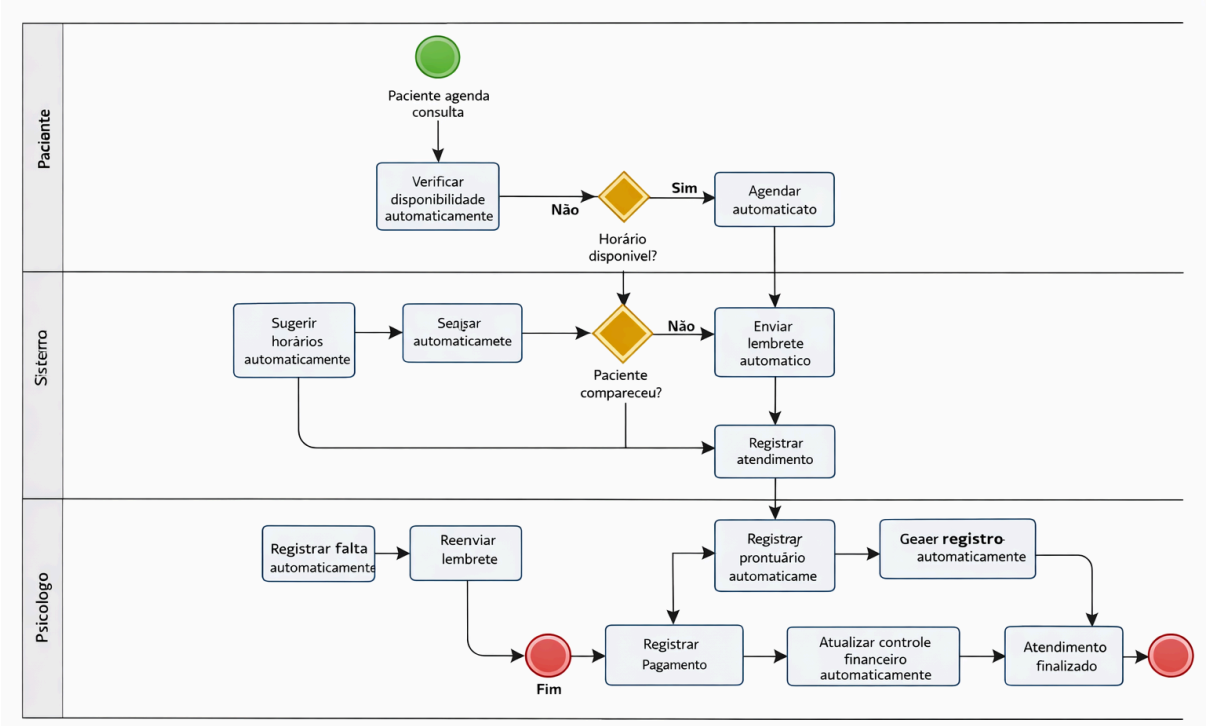
No modelo proposto, o sistema realiza automaticamente a verificação de disponibilidade, o agendamento de consultas, o envio de lembretes e a atualização do controle financeiro.

O processo inicia-se com o agendamento da consulta pelo paciente. O sistema verifica automaticamente a disponibilidade e agenda o atendimento. Em seguida, são enviados lembretes automáticos com possibilidade de confirmação.

No dia da consulta, o sistema registra automaticamente a presença ou ausência do paciente. Em caso de atendimento realizado, o prontuário é preenchido com apoio do sistema e o registro financeiro é gerado automaticamente.

Por fim, o pagamento é registrado e o sistema atualiza automaticamente o controle financeiro.

Figura 2 – Processo de agendamento e atendimento clínico (TO-BE)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5. REQUISITOS DO SISTEMA

5.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve oferecer aos usuários, considerando as necessidades levantadas.

RF01 – O sistema deve permitir o cadastro completo de pacientes, incluindo informações pessoais e de contato.

RF02 – O sistema deve permitir a consulta, edição e inativação de pacientes cadastrados.

RF03 – O sistema deve permitir o agendamento de consultas, informando data, horário, profissional e tipo de atendimento.

RF04 – O sistema deve impedir conflitos de horário na agenda dos profissionais.

RF05 – O sistema deve permitir o reagendamento e cancelamento de consultas, mantendo histórico dessas ações.

RF06 – O sistema deve enviar lembretes automáticos de consulta aos pacientes por meio de canais como WhatsApp e e-mail.

RF07 – O sistema deve permitir o registro de prontuário eletrônico estruturado por paciente.

RF08 – O sistema deve armazenar o histórico completo de atendimentos dos pacientes.

RF09 – O sistema deve permitir o registro de faltas e ausências.

RF10 – O sistema deve permitir o controle financeiro das consultas, incluindo registro de pagamentos.

RF11 – O sistema deve permitir a geração de relatórios de atendimentos e faturamento.

RF12 – O sistema deve permitir o acesso simultâneo de múltiplos usuários.

RF13 – O sistema deve possuir autenticação por login e senha.

RF14 – O sistema deve possuir controle de acesso baseado no perfil do usuário.

RF15 – O sistema deve integrar os módulos de agenda, prontuário e financeiro.

RF16 – O sistema deve permitir o envio e armazenamento de documentos relacionados aos pacientes.

5.2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais definem características de qualidade e restrições do sistema.

RNF01 – O sistema deve garantir segurança no acesso às informações.

RNF02 – O sistema deve garantir a privacidade dos dados dos pacientes, conforme a legislação vigente.

RNF03 – O sistema deve possuir interface simples, intuitiva e de fácil utilização.

RNF04 – O sistema deve apresentar desempenho adequado, com tempo de resposta rápido.

RNF05 – O sistema deve estar disponível durante o horário de funcionamento da clínica.

RNF06 – O sistema deve ser compatível com navegadores modernos.

RNF07 – O sistema deve possuir mecanismo de backup periódico dos dados.

RNF08 – O sistema deve registrar ações relevantes realizadas pelos usuários (auditoria).

5.3 Regras de Negócio

As regras de negócio representam restrições específicas do domínio da aplicação.

- RN01 – Toda consulta deve estar vinculada a um paciente cadastrado.
- RN02 – O acesso ao prontuário deve ser restrito a usuários autorizados.
- RN03 – Consultas canceladas não devem ser contabilizadas como realizadas.
- RN04 – Consultas realizadas devem gerar registros financeiros correspondentes.
- RN05 – Os dados clínicos dos pacientes devem ser tratados como confidenciais.

5.4 Casos de Uso

Os casos de uso representam as principais interações entre os usuários e o sistema.

- CU01 – Cadastrar paciente: o usuário insere os dados e o sistema registra as informações.
- CU02 – Agendar consulta: o sistema verifica a disponibilidade e registra o atendimento.
- CU03 – Registrar prontuário: o profissional registra as informações da sessão.
- CU04 – Registrar pagamento: o sistema atualiza o status financeiro.

5.5 Interfaces do Sistema

O sistema deverá disponibilizar interface com as seguintes telas:

- login
- painel principal (dashboard)
- agenda
- cadastro de pacientes
- prontuário
- financeiro
- relatórios

Também poderá integrar-se com serviços externos, como envio de mensagens e plataformas de pagamento.

5.6 Critérios de Aceitação

Os critérios de aceitação definem condições para validação do sistema.

- O sistema deve permitir cadastro correto de pacientes.
- O sistema não deve permitir conflitos de agendamento.
- O prontuário deve ser acessível apenas por usuários autorizados.
- Os pagamentos devem ser registrados corretamente.
- Os lembretes devem ser enviados automaticamente.

5.7 Diferenciais do Sistema

- Integração completa entre módulos
- Automação da comunicação com pacientes
- Suporte a múltiplos profissionais
- Possibilidade de uso de inteligência artificial no prontuário

6. MATRIZ DE RASTREABILIDADE

6.1 Visão Geral

A matriz de rastreabilidade a seguir relaciona os requisitos do sistema às suas respectivas fontes de origem, considerando entrevistas, questionários e análise de sistema análogo. A consolidação dessas fontes permite identificar quais requisitos são diretamente demandados pelos usuários e quais foram inferidos a partir de boas práticas ou análise de mercado.

6.2 Matriz de Rastreabilidade

ID	Requisito	Entrevistas	Questionários	Sistema Análogo	Justificativa
RF01	Cadastro de pacientes	✔	✔	✔	Funcionalidade básica presente no fluxo atual e em sistemas existentes.
RF02	Gestão de pacientes	✔	✔	✔	Necessidade de manutenção e consulta de dados identificada em todas as fontes.
RF03	Agendamento de consultas	✔	✔	✔	Principal atividade do sistema, recorrente em todas as análises.
RF04	Controle de conflitos de agenda	✔	✔	⚠	Problema relatado pelos usuários; implícito em sistemas reais.
RF05	Reagendamento e cancelamento	✔	✔	✔	Processo comum na rotina das clínicas.
RF06	Lembretes automáticos	✔	✔	✔	Necessidade direta para redução de faltas.
RF07	Prontuário eletrônico	✔	✔	✔	Elemento central para registro clínico.
RF08	Histórico de atendimentos	✔	✔	✔	Derivado do prontuário e acompanhamento do paciente.
RF09	Registro de faltas	✔	✔	✔	Relacionado à gestão da agenda.
RF10	Controle financeiro	✔	✔	✔	Necessidade operacional presente em todas as fontes.
RF11	Relatórios	⚠	✔	✔	Mais evidente em sistemas e questionários do que nas entrevistas.

RF12	Multiusuário	✔	✔	⚠	Necessário para clínicas com mais de um profissional.
RF13	Autenticação	⚠	⚠	✔	Requisito técnico padrão em sistemas similares.
RF14	Controle de acesso	⚠	⚠	✔	Derivado da necessidade de perfis de usuário.
RF15	Integração entre módulos	✔	✔	✔	Necessidade de centralização identificada nas entrevistas.
RF16	Upload de documentos	✔	✔	⚠	Demanda dos usuários, pouco explorada no sistema analisado.

6.3 Requisitos Não Funcionais

ID	Requisito	Entrevistas	Questionários	Sistema Análogo	Justificativa
RNF01	Segurança	✔	✔	✔	Forte preocupação com dados sensíveis.
RNF02	Privacidade (LGPD)	✔	✔	✔	Exigência legal e necessidade dos usuários.
RNF03	Usabilidade	✔	✔	✔	Usuários buscam simplicidade no uso.
RNF04	Desempenho	⚠	⚠	✔	Inferido a partir de boas práticas.
RNF05	Disponibilidade	⚠	⚠	✔	Esperado em sistemas web.
RNF06	Compatibilidade	⚠	⚠	✔	Necessidade técnica implícita.
RNF07	Backup	⚠	⚠	✔	Requisito de segurança de dados.

RNF08	Auditabilidade	⚠	⚠	✔	Relacionado à segurança e rastreabilidade.

6.4 Análise Consolidada

A análise da matriz evidencia que os requisitos funcionais principais — especialmente aqueles relacionados à agenda, prontuário e controle financeiro — possuem origem consistente entre entrevistas, questionários e sistemas analisados, o que reforça sua relevância para o sistema proposto.

Por outro lado, requisitos de natureza técnica, como autenticação, controle de acesso e aspectos de desempenho, não foram explicitamente mencionados pelos usuários, sendo incorporados com base em boas práticas de desenvolvimento e análise do sistema análogo.

Além disso, observa-se que as entrevistas contribuíram principalmente com a identificação de problemas reais e necessidades práticas, enquanto os questionários permitiram validar padrões de uso. Já a análise do sistema análogo auxiliou na definição da estrutura funcional esperada para esse tipo de solução.